

	CONSENTIMIENTO INFORMADO PROCEDIMIENTOS	Código: FO-HCR-01
		Versión: 04
		Fecha: octubre 2025

Fecha de diligenciamiento: DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____

Paciente:						
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	Edad	Documento	Teléfono

Personal de Salud Responsable del Procedimiento			
	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres

Definición de Consentimiento Informado: Es la autorización que el paciente (o su representante) confiere al profesional de la salud para la realización de procedimiento en **Especialistas En Casa**, previa información oportuna, clara y precisa de lo que se le va a realizar, sus objetivos, alternativas y riesgos. (Es responsabilidad del profesional de salud el correcto diligenciamiento del consentimiento).

Diagnóstico: _____

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	BENEFICIOS	RIESGOS	IMPLICACIONES/ CONSECUENCIAS	POSIBLES ALTERNATIVAS	Marque con una X
Cateterismo Venoso Periférico: consiste en la inserción de un catéter (un tubo delgado y flexible) en una vena periférica, generalmente en el brazo o la mano, para administrar medicamentos, líquidos o para extraer sangre.	• Permite la administración rápida y efectiva de medicamentos y líquidos. • Facilita la extracción de muestras de sangre sin necesidad de múltiples punciones. • Es un procedimiento relativamente sencillo y rápido de realizar.	• Infección en el sitio de inserción. • Flebitis (inflamación de la vena). • Extravasación (fuga de líquidos fuera de la vena). • Hematomas o sangrado en el sitio de inserción. • Reacciones alérgicas al material del catéter.	• Necesidad de monitoreo continuo del sitio de inserción para detectar signos de infección o complicaciones. • Posible necesidad de reemplazo del catéter si se presentan complicaciones. • En caso de infección, puede requerirse tratamiento con antibióticos.	• Administración de medicamentos por vía oral o intramuscular. • Uso de un catéter central si se requiere acceso venoso prolongado o administración de medicamentos irritantes. • Terapia subcutánea para la administración de ciertos medicamentos.	
Paso de sonda vesical Nasogástrica y/o orogástrica: consiste en la inserción de un tubo flexible a través de la nariz (nasogástrica) o la boca (orogástrica) hasta el estómago. Este procedimiento se utiliza para la administración de alimentos, líquidos, medicamentos, o para la extracción de contenido gástrico.	• Permite la administración de nutrición y medicamentos en pacientes que no pueden ingerir alimentos por vía oral. • Facilita el drenaje de contenido gástrico en casos de obstrucción intestinal o para descompresión gástrica. • Ayuda en la realización de lavados gástricos en casos de intoxicación.	• Irritación o lesión de la mucosa nasal, esofágica o gástrica. • Riesgo de aspiración pulmonar si la sonda no se coloca correctamente. • Infección en el sitio de inserción. • Desplazamiento o bloqueo de la sonda. • Molestias o dolor durante la inserción y uso de la sonda.	• Necesidad de monitoreo continuo para asegurar la correcta posición de la sonda y evitar complicaciones. • Posible necesidad de reemplazo de la sonda si se presenta obstrucción o desplazamiento. • En caso de complicaciones, puede requerirse intervención médica adicional.	• Administración de medicamentos y nutrición por vía intravenosa. • Uso de una sonda de gastrostomía para acceso directo al estómago en casos de necesidad prolongada. • Alimentación parenteral total (TPN) en casos donde no es posible el uso de la vía digestiva.	
Curaciones: consisten en la limpieza, desinfección y protección de heridas para promover su cicatrización y prevenir infecciones. Mediante el uso de soluciones antisépticas, apósitos especiales, convencionales y la evaluación periódica del estado de la herida.	• Promueve la cicatrización adecuada de la herida. • Previene infecciones y complicaciones. • Reduce el dolor y la inflamación asociados a la herida. • Permite la evaluación continua del progreso de la cicatrización.	• Posible dolor o molestia durante el procedimiento. • Riesgo de infección si no se siguen las técnicas asépticas adecuadas. • Reacciones alérgicas a los materiales utilizados (apósitos, soluciones antisépticas). • Posible sangrado o daño adicional a la herida durante la manipulación.	• Necesidad de realizar curaciones frecuentes hasta la completa cicatrización de la herida. • Monitoreo continuo para detectar signos de infección o complicaciones. • En caso de infección, puede requerirse tratamiento adicional con antibióticos.	• Uso de apósitos avanzados que requieren menos cambios y manipulación. • Terapia de presión negativa para heridas complejas. • Tratamiento con antibióticos tópicos o sistémicos en caso de infección. • Plan de manejo por jefe de clínica de heridas, según la evolución observada en la valoración periódica de la lesión que puede variar a las	

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	BENEFICIOS	RIESGOS	IMPLICACIONES/ CONSECUENCIAS	POSIBLES ALTERNATIVAS	Marque con una X
			• Posible necesidad de intervención médica si la herida no cicatriza adecuadamente.	indicaciones iniciales enviadas por la entidad remitente. • En algunos casos, puede considerarse la intervención quirúrgica para la limpieza y cierre de la herida.	
Administración y aplicación de medicamentos: implica la entrega de fármacos al paciente a través de diversas vías, como oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea, entre otras. Este procedimiento se realiza para tratar enfermedades, aliviar síntomas o prevenir condiciones médicas.	• Tratamiento efectivo de enfermedades y condiciones médicas. • Alivio de síntomas como dolor, fiebre, inflamación, entre otros. • Prevención de enfermedades mediante la administración de vacunas. • Mejora de la calidad de vida del paciente.	• Reacciones adversas o alérgicas a los medicamentos. • Errores en la dosificación o en la vía de administración. • Infección en el sitio de inyección (en caso de administración parenteral). • Interacciones medicamentosas que pueden afectar la eficacia o seguridad del tratamiento.	• Necesidad de monitoreo continuo para detectar y manejar posibles efectos adversos. • Posible ajuste de la dosis o cambio de medicamento en caso de reacciones adversas. • Educación al paciente sobre la correcta administración y adherencia al tratamiento. • En caso de complicaciones, puede requerirse intervención médica adicional.	• Terapias no farmacológicas, como fisioterapia, cambios en el estilo de vida o terapias complementarias. • Uso de medicamentos alternativos con un perfil de seguridad diferente. • Ajustes en la dieta y hábitos de vida para mejorar la condición médica sin necesidad de medicamentos. • En algunos casos, puede considerarse la intervención quirúrgica si es una opción viable.	
Retiro de puntos: consiste en la extracción de las suturas que se colocaron previamente para cerrar una herida. Este procedimiento se realiza generalmente entre 7 y 14 días después de la cirugía, y/o por dehiscencia de las mismas, y/o por previa orden médica dependiendo del tipo de herida y su ubicación.	• Permite la finalización del proceso de cicatrización. • Reduce el riesgo de infección asociado con la permanencia prolongada de las suturas. • Mejora el aspecto estético de la cicatriz. • Facilita la movilidad y comodidad del paciente.	• Dolor o molestia durante el procedimiento. • Posible sangrado leve en el sitio de la herida. • Riesgo de infección si no se siguen las técnicas asépticas adecuadas. • Dehiscencia (reapertura) de la herida si se retiran los puntos prematuramente.	• Necesidad de monitoreo continuo del sitio de la herida para asegurar una cicatrización adecuada. • Posible necesidad de aplicar apósitos o antisépticos después del retiro de los puntos. • En caso de complicaciones, puede requerirse intervención médica adicional.	• Uso de suturas absorbibles que no requieren retiro. • Aplicación de adhesivos cutáneos o grapas quirúrgicas, dependiendo del tipo de herida. • En algunos casos, puede considerarse el uso de apósitos avanzados que promuevan la cicatrización sin necesidad de suturas.	
Toma de un electrocardiograma (EKG): es un procedimiento no invasivo que registra la actividad eléctrica del corazón. Se colocan electrodos en la piel del paciente, generalmente en el pecho, brazos y piernas, que están conectados a una máquina que registra las señales eléctricas del corazón.	• Permite la detección de arritmias, isquemia miocárdica, infartos previos y otras anomalías cardíacas. • Ayuda en el diagnóstico y monitoreo de enfermedades cardíacas. • Es un procedimiento rápido, seguro y no invasivo. • Proporciona información valiosa para la toma de decisiones clínicas.	• Posible irritación o reacción alérgica en la piel donde se colocan los electrodos. • Incomodidad temporal debido a la colocación de los electrodos. • En casos muy raros, puede haber interferencia con dispositivos médicos implantados, como marcapasos.	• No se requieren cuidados especiales después del procedimiento. • Los resultados del EKG pueden llevar a la necesidad de pruebas adicionales o cambios en el tratamiento. • Es importante interpretar los resultados en el contexto clínico del paciente.	• Monitoreo Holter, que registra la actividad cardíaca durante 24-48 horas. • Prueba de esfuerzo, que evalúa la función cardíaca durante el ejercicio. • Ecocardiograma, que utiliza ultrasonido para visualizar la estructura y función del corazón. • Resonancia magnética cardíaca (RMN) para una evaluación más detallada de la anatomía y función cardíaca.	
Retiro de Catéter PICC en Domicilio es un procedimiento que consiste en retirar el catéter venoso	• Prevención de infecciones por uso prolongado del catéter.	• Sangrado leve o hematoma en el sitio de inserción.	• El procedimiento requiere autorización médica expresa.	• Retiro del PICC en ambiente hospitalario con equipo multidisciplinario.	

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	BENEFICIOS	RIESGOS	IMPLICACIONES/ CONSECUENCIAS	POSIBLES ALTERNATIVAS	Marque con una X
central de inserción periférica (PICC) en el entorno domiciliario por parte del personal capacitado bajo supervisión médica o de enfermería profesional. El procedimiento consiste en la extracción cuidadosa del catéter PICC que se encuentra alojado en una vena profunda del brazo, utilizado para administración de medicamentos prolongados o nutrición parenteral. Se realiza con técnica estéril, previa valoración del estado del sitio de inserción, signos vitales y orden médica vigente.	• Retiro oportuno de un dispositivo ya no necesario. • - Mayor comodidad para el paciente y reducción del riesgo de complicaciones asociadas.	• Dolor, inflamación o enrojecimiento local. • Retención parcial del catéter por adherencia o fijación venosa. • Riesgo de infección si no se realiza bajo condiciones de asepsia. • Embolismo por ruptura o tracción incorrecta del catéter.	• En caso de complicaciones durante el retiro, puede requerirse traslado a una institución de salud. • El paciente puede experimentar ansiedad o sensación leve de incomodidad durante el procedimiento.	• Esperar hasta una evaluación médica presencial si existen signos de complicaciones. • Cambio del PICC por otro acceso venoso si aún se requiere tratamiento intravenoso. Actuar en caso de: • Fijación aparente, • Dolor excesivo o signos de sangrado/incomodidad grave, se debe: - Suspender inmediatamente el procedimiento. - No ejercer fuerza ni maniobras adicionales. - Cubrir el sitio de inserción con apósito estéril y asegurar la estabilidad del catéter. - Informar de forma inmediata al médico responsable. - Registrar la situación en el formato de atención domiciliaria y notificar a la EPS o IPS correspondiente. - Recomendar al paciente y familia no manipular el catéter hasta nueva orden clínica.	

ENTIENDO MI MODALIDAD DE ATENCIÓN Y CONSENTO - ACEPTO -EN SER TRATADO POR UN PROFESIONAL DE MEDICINA

HUELLA PACIENTE		
	Firma del Paciente	Cedula del Paciente
	Firma y Cedula del acudiente o testigo	Firma y sello o registro del personal de la salud

NO CONSENTIMIENTO

Con pleno conocimiento de los riesgos y después de haber sido informado, he decidido **no aceptar** la realización del procedimiento, haciéndome responsable de las consecuencias que se puedan derivar de esta decisión.

Huella Paciente		
	Firma y cedula del Paciente	Firma y cedula del acudiente o testigo
	Firma y sello o registro del personal de la salud	